

Anémie : Résidanat 2025

DR Ben YOUSSEF , Dr BOUTERAA

Cas clinique n° 1 :

Lors d'un entretien d'embauche, on découvre chez un patient les données de la numération suivantes :

- Hémoglobine à 10 g/dl ; VGM :85fl . CCMH à 40 ; Plaquettes à 400 000/mm³
GB à 8 500/mm³ (PNN 5 200) réticulocytes : 130 000/mm³
- A l'examen clinique : splénomégalie à 2 cm
- A l'examen biologique : BT/BD = 50/12 ; LDH = 350UI/L

1- Le bilan biologique montre :

- A- Anémie normochrome normocytaire
- B- Thrombopénie
- C- Stigmate de l'hémolyse
- D- Hyperbilirubénémieconjugée
- E- Globules blancs normaux

2- Quel est le mécanisme de l'anémie ?

- A- Anémie d'origine centrale
- B- Anémie hémolytique
- C- Hémolyse intra tissulaire
- D- Anémie par carence en fer
- E- Anémie par défaut de synthèse de l'érythropoïétine

3- Le diagnostic le plus probable

- A- PTT
- B- Microsphérocytose héréditaire
- C- Déficit en G6PD
- D- Thalassémie
- E- Maladie de Minkowski Chauffard

4- Comment confirmer le diagnostic ?

- A-Test de résistance osmotique globulaire
- B- Cytométrieen flux
- C- Electrophorèse de l'hémoglobine
- D -Ektacytométrie
- E – Myélogramme

Cas clinique n° 2 :

Un patient âgé de 20 ans suivi pour une drépanocytose homozygote depuis l'enfance consulte pour des rachialgies + douleur des membres inférieurs évoluant depuis 2 jours.

1- Le bilan biologique peut montrer :

- A- Anémie microcytaire régénérative
- B- Des stigmates d'hémolyse
- C- Aufrottis sanguin : Présence de sphérocytes
- D- Test d'Emmel positif
- E- Une thrombopénie

2- Les complications aiguës de la maladie sont :

- A- AVC ischémique
- B- IDM
- C- Crise vaso-occlusive
- D- Syndrome Pied main
- E- Séquestration splénique

3- Le traitement de ce patient comporte :

- A- Acide folique
- B- Hyper hydratation
- C- Fer oral
- D- antalgique
- E- anti coagulants

4- Après 2 ans, le patient consulte les urgences pour une douleur thoracique aiguë dans un contexte fébrile. Quels sont les diagnostics probables ?

- A- Syndrome thoracique aigu
- B- IDM
- C- Pneumopathie
- D- Pneumothorax
- E- Embolie pulmonaire

5- Le traitement consiste :

- A- Antibiotiques
- B- Hyperhydratation
- C- Echange transfusionnel
- D- Transfusion simple
- E- Anti-coagulant

Cas clinique n° 3 :

Un enfant âgé de 8 ans s'est présenté aux urgences pour une douleur abdominale aigue, fièvre, notion d'urines rouges d'installation brutale suite à la prise du Bactrim.

A la biologie : GB = 6 500 (5 pnn 4000) ; Hb = 4 ; VGM = 82 ; Plq = 350 000 ; Rétic = 180 000/mm³

LDH = 1000 UI/L ; Haptoglobine = 0,01 ; BT/BD = 45/15

Culot urinaire : hémoglobinurie positive

1) Le bilan biologique comporte :

- A- Anémie régénérative
- B- Stigmate d'hémolyse
- C- Anémie normocytaire
- D- Hématurie à l'ECBU
- E- Thrombopénie

2) Quel est le mécanisme de l'anémie ?

- A- Anémie d'origine périphérique
- B- Anémie hémolytique
- C- Anémie par carence en B12
- D- Hémolyse intra vasculaire
- E- Anémie par infiltration de la moelle

3) Quel est le diagnostic le plus probable

- A- Anémie hémolytique auto-immune
- B- Drépanocytose
- C- Déficit en G6BD
- D- Microsphénocytose
- E- Thalassémie

Cas clinique n° 4 :

Un patient, âgé de 70 ans, consulte pour un syndrome anémique évoluant depuis une semaine.

A l'examen :

- Poly ADP cervicales 1 à 2 cm bilatérales
- Ictère conjonctival
- Splénomégalie à 3 cm du RC

1) Quel est le bilan biologique à demander de 1ère intention ?

- A- NFS + FS
- B- Scanner corps entier
- C- Bilan d'hémolyse
- D- Myélogramme
- E- TCD

2) A la NFS on trouve une hyper lymphocytose avec au FS présence de lymphocytes matures.

Le diagnostic le plus probable :

- A- Leucémie aigue lymphoblastique
- B- Myélofibrose
- C- LMC
- D- LLC
- E- Myélome

3- Le bilan biologique montre une TCD positif.

Ces réponses sont vraies :

- A- Il s'agit d'une AHAI
- B- L'anticorps est de type froid
- C- Le traitement repose sur la corticothérapie
- D- Au FS on trouve des schizocytes
- E- On doit prescrire de la foldine

Cas clinique n° 5:

Une femme, âgée de 27 ans sans antécédents, consulte pour asthénie évoluant depuis 06 mois avec notion de ménométrorragies.

L'examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse, ongles striés et cassants et un herpes labial bilatéral.

L'hémogramme retrouve : GB = 7 600 elt/mm³, Hb = 6,3 g/dl ; VGM = 62 fl ; CCMH = 30 % GR = 3,8 106/mm³ ; plaquettes = 680 000/mm³.

1) Parmi les diagnostics suivants :

- A- Anémie par carence en facteur antipernicieux
- B- Insuffisance rénale chronique
- C- Anémie ferriprive
- D- Anémie inflammatoire
- E- Une Béta thalassémie mineurs

2) Quels sont les signes cliniques en faveur de votre diagnostic ?

- A- L'âge de la patiente
- B- La pâleur cutanéomuqueuse
- C- Chute des cheveux, ongles striés et cassants
- D- Herpès labial bilatéral
- E- l'évolution de la symptomatologie

3) Quel examen clé nécessaire pour confirmer votre diagnostic

- A- Electrophorèse de l'hémoglobine
- B- Dosage de la ferritinémie
- C- Myélogramme
- D- Bilan rénal
- E- Bilan inflammatoire (VS, CRP)

4) Quelle est votre conduite à tenir ?

- A- Mettre la patiente sous traitement martial
- B- Mettre la patiente sous Vitamine B12 + Acide folique
- C- Orienter la patiente vers un gynécologue
- D- Transfuser la patiente
- E- Mettre la patiente sous Fer + Folate

QCM 1 Au cours des anémies hémolytiques autoimmunes de l'adulte, les auto-anticorps les plus fréquemment rencontrés sont :

- A. Anti ABO
- B. Anti-Rhésus
- C. Anti-Kell
- D. Anti-Duffy
- E. Anti-Ii

QCM 2 on peut rencontrer une anémie macrocytaire :

- A. Chez un malade ayant une carence en fer
- B. Chez un malade ayant une carence en vitamine D
- C. Chez un malade ayant une Maladie de Biermer
- D. Chez un malade ayant une maladie cœliaque
- E. Chez un gastrectomisé total

QCM 3 la survenue brutale d'une anémie sévère avec douleurs lombaires, ictère à bilirubine non conjuguée, urines foncées avec hémoglobinurie est compatible avec :

- A. Une anémie hémolytique intravasculaire
- B. Une anémie hémolytique intratissulaire
- C. Un déficit en G6PD
- D. Une Béta-thalassémie mineure
- E. Une AHAI

QCM4 Indiquez parmi les propositions suivantes celles qui sont à l'origine d'une microcytose des GR

- A. Diminution du nombre de mitoses du proérythroblaste au réticulocyte et au GR
- B. Anomalie de la synthèse de l'hème
- C. Anomalie de la synthèse des chaînes de la globine
- D. Anomalie de la synthèse de l'ADN nucléaire érythroblastique
- E. Déficit de sécrétion d'érythropoïétine

QCM 5 un patient drépanocytaire SS présente une anémie. Celle-ci peut être en rapport avec :

- A. Erythroblastopénie
- B. Inflammation
- C. Séquestration splénique
- D. Une origine carencielle
- E. Crise d'hyperhémolyse

QCM6. Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle ou quelles sont qui s'appliquent à une anémie par inflammation chronique ?

- A. L'anémie peut être macrocytaire
- B. Le taux de la transferrine est normal ou modérément diminué
- C. L'anémie est habituellement régénérative
- D. Le traitement martial améliore le chiffre d'hémoglobine
- E. L'hyposidérémie est constante